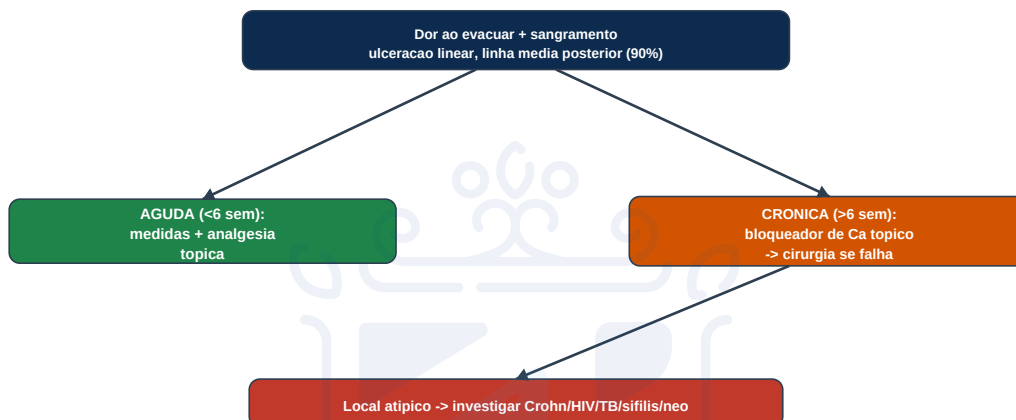


FISSURA ANAL — AGUDA x CRÔNICA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

FISSURA ANAL — TEMPO + LOCALIZAÇÃO



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

O QUE É

- Ulceração linear distal à linha pectínea, tipicamente na LINHA MÉDIA POSTERIOR (90%) ou anterior
- Etiologia: constipação (principal), diarreia volumosa, sexo anal, trauma anal
- Fisiopatologia: hipertonia do esfíncter interno + isquemia local dificultam a cicatrização (linha média posterior é a menos vascularizada)
- FISSURAS ATÍPICAS (laterais, múltiplas, irregulares) -> investigar Crohn, HIV, tuberculose, sífilis, neoplasia
- Clínica clássica: dor intensa ao evacuar (e após) + sangramento vivo em pequena quantidade

AGUDA x CRÔNICA

Tipo	Características
Aguda (< 6 semanas)	Dor ao evacuar, sangramento, associação com constipação; ferida recente
Crônica (> 6 semanas)	Hipertrofia esfinteriana, úlcera esbranquiçada, PLICOMA SENTINELA, papila hipertrófica (tríade da cronicidade)

TRATAMENTO CLÍNICO

Rx MEDIDAS + TÓPICOS

Regularização do hábito evacuatório: aumento de fibras e água; laxativo se constipação associada

Banho de assento (relaxa o esfíncter, alívio sintomático)

AGUDA: pomada anestésica/cicatrizante local 2-3x/dia por ~14 dias; Lidocaína tópica 2% 2-3x/dia por 2-3 semanas

CRÔNICA: bloqueador de canal de cálcio TÓPICO — Diltiazem 2% na borda anal 3x/dia por 6-8 semanas (ou nitroglicerina tópica)

Analgesia oral: Cetoprofeno 100 mg 12/12h por 4-6 dias; Dipirona 1 g 6/6h se dor

TRATAMENTO CIRÚRGICO

QUANDO FALHA O CLÍNICO

- ESFINCTEROTOMIA LATERAL INTERNA: padrão-ouro cirúrgico para fissura crônica refratária (alivia a hipertonia)
- Toxina botulínica (Botox): alternativa que reduz o tônus esfinteriano sem incisão
- Risco da esfinterotomia: incontinência (sobretudo a flatos) — selecionar bem o paciente
- Cuidado especial em mulheres multíparas e em portadores de Crohn (preferir medidas conservadoras/Botox)
- Antes de operar fissura atípica/lateral, EXCLUIR doença de base

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com dor ao evacuar + sangramento; fissura ____ (aguda/crônica), localização ____ (posterior/atípica).
- Sinais de cronicidade (plicoma/papila/úlcera esbranquiçada): ____; suspeita de doença de base: ____.
- Conduta: medidas dietéticas, banho de assento, tópico ____ (lidocaína/diltiazem), analgesia.
- Encaminhamento à proctologia se refratária (> 6-8 semanas) para esfinterotomia/Botox; investigar Crohn/HIV/TB se atípica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a localização mais comum da fissura anal típica?

- A) Lateral esquerda
- B) Linha média posterior (~90%)
- C) Circunferencial
- D) Linha média lateral direita
- E) Anterior exclusivamente

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado caracteriza a fissura anal CRÔNICA?

- A) Ferida recente sem outras alterações
- B) Plicoma sentinela, papila hipertrófica e úlcera esbranquiçada com hipertrofia esfinteriana
- C) Sangramento volumoso
- D) Febre alta
- E) Massa pulsátil

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a medicação tópica de escolha para a fissura anal crônica?

- A) Corticoide tópico
- B) Bloqueador de canal de cálcio tópico (diltiazem 2%) ou nitroglicerina tópica
- C) Antibiótico tópico
- D) Antifúngico tópico
- E) Apenas vaselina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Fissura anal em localização atípica (lateral, múltipla) deve levantar suspeita de:

- A) Constipação simples
- B) Doença de Crohn, HIV, tuberculose, sífilis ou neoplasia
- C) Apenas trauma
- D) Hemorroida
- E) Diverticulite

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o tratamento cirúrgico padrão-ouro da fissura anal crônica refratária?

- A) Hemorroidectomia
- B) Esfincterotomia lateral interna
- C) Amputação abdominoperineal
- D) Retopexia
- E) Fistulotomia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A fissura típica localiza-se na linha média posterior em ~90% dos casos (área menos vascularizada, propensa à isquemia/hipertonia); pode ser anterior, sobretudo em mulheres.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A cronicidade (> 6 semanas) cursa com plicoma sentinela, papila hipertrófica e úlcera esbranquiçada, com hipertrofia/hipertonia do esfíncter interno.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na fissura crônica usa-se bloqueador de canal de cálcio tópico (diltiazem 2%) ou nitroglicerina tópica, que reduzem o tônus esfinteriano e melhoram a perfusão para cicatrização.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Fissuras atípicas (laterais, múltiplas, irregulares) exigem investigar doença de base: Crohn, HIV, tuberculose, sífilis e neoplasia.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A esfínterectomia lateral interna é o padrão-ouro cirúrgico na fissura crônica refratária; o Botox é alternativa. Atenção ao risco de incontinência.

SM24
Suporte ao Plantão Médico